

의료기관 AI 활용검정 · 비임상

AXIS-H L1 수험 가이드

의료기관의 AI 운영을 설계하세요

"AI를 제일 잘 쓰나요?"가 아니라

"의료기관이 비임상 업무에 AI를 안전하게 도입·운영하도록 기준을 설계할 수
있나요?"를 봅니다.

의료행위 판단이 아니라, 비임상 AI 운영체계를 설계하는 리더 시험이에요.

객관식 25문항

실행계획서 +서술형

시험시간 120분

합격 70점 이상



차근차근 살펴봐요

궁금한 순서대로 담았습니다

1

AXIS-H L1은 어떤 시험인가요?

비임상 운영 설계 리더 시험

03

2

누가 보면 좋고, 어떤 능력이 필요한가요?

응시 대상과 갖추면 좋은 역량

04

3

시험은 어떻게 구성되나요?

객관식 25 + 실행계획서 + 서술형 한눈에

05

4

어떤 기준으로 문제가 나오나요?

6대 평가영역과 출제 유형

06

5

실행계획서·서술형은 어떻게 치르나요?

Part B·C와 채점 방식

07

6

어떻게 채점하고, 언제 합격인가요?

배점과 합격 기준

08

7

무엇을 어떻게 준비하면 되나요?

영역별 학습 방향

09

8

시험 볼 때 주의할 점은?

본인확인 절차와 흔한 실수

10

9

시험이 끝나면, 그다음은?

결과·자격증·재응시·다음 단계

11



이 가이드는 이렇게 쓰세요. AXIS-H L1은 "의료기관의 비임상 AI 운영체계를 설계하는" 리더 시험입니다. 의료행위 판단은 다루지 않아요. 전체를 한 번 읽으면 그림이 잡혀요. 막막하다면 7번을, 임박했다면 8번을 먼저 보셔도 좋습니다.

1 AXIS-H L1은 어떤 시험인가요?

비임상 운영 설계 리더 시험이에요

먼저 분명히 할게요. AXIS-H L1의 핵심은 **의료행위 판단이 아닙니다**. L2가 "의료기관 비임상 산출물을 만들고 검증하는가"를 봤다면, L1은 그 위에서 **의료기관이 비임상 업무에 AI를 안전하게 도입·운영하도록 기준과 체계를 설계할 수 있는가**를 봅니다. 비임상 적용범위, 환자정보 보호, 산출물 품질관리, 의료윤리·컴플라이언스 체계를 만드는 **리더의 역량**을 보는 시험이에요. **진단·치료·처방 판단은 설계 대상에 포함되지 않습니다**.

● 혼한 생각 vs 실제로 보는 능력

L1을 "고급 의료 AI 시험"으로 오해하기 쉽지만, 실제로는 다릅니다. 핵심은 개인의 AI 실력이나 의학 지식이 아니라 **의료기관의 비임상 AI를 안전하게 굴러가게 만드는 운영 설계 능력**이에요.

이렇게 생각하기 쉬워요

- ✕ AI 진단·의료 AI를 잘 알면 된다
- ✕ 최신 의료 AI 도구를 많이 나열한다
- ✕ 임상 의사결정까지 AI로 설계한다
- ✕ 멋진 도입계획서를 자유롭게 쓴다
- ✕ 기술 용어를 많이 외운다

실제로는 이것을 봅니다

- ✓ 비임상 AI 활용 범위와 금지 경계를 설정한다
- ✓ 환자정보 입력·마스킹 기준을 설계한다
- ✓ 산출물 검토·승인 체계를 만든다
- ✓ 의료윤리·법적 책임·컴플라이언스를 통제한다
- ✓ 다직종 협업·교육·성과관리를 계획한다

 **한 문장으로 정리하면** — AXIS-H L1은 "의료 AI를 잘 아는 것"이 아니라 "**의료기관의 비임상 AI가 안전하게 운영되도록 적용범위·환자정보·품질·윤리 체계를 만드는**" 리더의 설계 능력을 봅니다. 핵심 과제가 **비임상 AI 운영 실행계획서 작성**이에요.

● 그래서 이런 점이 좋아요

- **의료기관 AI 도입을 이끄는 리더 역량을 증명**합니다. 병원 AI 추진 담당자·관리자에게 강력한 자격이 돼요.
- **안전한 비임상 AI 확산 능력이 길러집니다**. 시험 준비가 곧 병원의 AI 거버넌스·컴플라이언스 설계 실력으로 이어져요.
- **AI 실력만이 아니라 환자정보·의료윤리·변화관리**를 아우르는 종합 역량을 갖춘 리더임을 보여줍니다.

2 누가 보면 좋고, 어떤 능력이 필요한가요?

응시 대상과 갖추면 좋은 역량

● 이런 분께 딱 맞아요

- 의료기관의 AI 도입을 이끄는 관리자·리더 — 비임상 AI 운영 기준과 거버넌스를 설계해야 하는 분
- 부서의 AI 활용을 책임지는 부서장 — 원무·간호행정·CS·감염안전·홍보 등 부서별 적용을 설계하는 분
- 병원 QI·정보보호·기획 담당자 — 환자정보 보호와 컴플라이언스 체계를 만들어야 하는 분
- AXIS-H L2를 취득하고 리더 단계로 나아가려는 분

● 응시 자격 — L2 취득자를 권장해요

L1은 의료기관 운영체계를 설계하는 리더 시험이라, **비임상 산출물 수준을 이해하는 것**이 전제됩니다. 그래서 L2 취득자를 우선 권장합니다. 다만 운영 단계에 따라 예외도 있어요.

운영 단계	응시 자격 권장
초기 운영	L2 취득자 우선. 단, 관리자 경력 또는 L1 준비교육 이수자는 예외 응시 허용
정식 운영	L2 취득자 또는 이에 준하는 실무경력·교육이력 검증자
장기 운영	L2 취득 후 L1 응시 원칙 (자격 체계의 단계성 강화)



L2를 꼭 먼저 따야 하나요? 초기에는 관리자 경력이나 준비교육으로 예외 응시가 가능하지만, L1은 **L2의 비임상 산출물 제작·검증 능력을 이해한다는 전제**로 설계됩니다. 실무 감각 없이 운영 설계만 하면 현실성이 떨어지니, 가능하면 L2부터 차근차근 밟는 걸 권합니다.

● AXIS-H 등급 중 내 위치는?

AXIS-H도 직급·역량에 따라 3단계로 나뉘어요. **L1은 가장 높은 단계**로, 의료기관을 이끄는 리더의 역량을 증명하는 등급입니다.

등급	누가 보나요?	무엇을 보나요?
L3 Starter	비임상 실무 입문자	의료기관 AI 안전 활용
L2 Practitioner	비임상 실무자	의료기관 산출물 제작·검증
L1 Leader 👉 지금 여기	관리자·리더	의료기관 AI 운영체계 설계

3 시험은 어떻게 구성되나요?

문항 수 · 시간 · 배점 한눈에

3파트

객관식 + 실행계획서 + 서술형

120분

충분한 설계 시간 확보

100점

70점 이상 합격

● 시험 구성 한눈에 보기

파트	구성	시간	배점	평가 초점
Part A	사례형 객관식 25문항	30분	25점	리더 수준의 비임상 전략·거버넌스·환자정보 판단
Part B	비임상 AI 운영 실행계획서 1개	60분	55점	적용범위·환자정보·품질·윤리·컴플라이언스 설계
Part C	리스크·변화관리 서술형 2문항	30분	20점	환자정보 사고·저항 관리·성과부진 등 대응
합계	객관식+설기+서술형	120분	100점	의료기관 조직설계형 리더 역량 종합 검정

※ Part B 실행계획서가 55점으로 비중이 압도적입니다. L1은 "지식"이 아니라 실제로 의료기관 비임상 AI 운영체계를 설계하는 능력이 핵심인 시험이에요.

● 세 파트는 이렇게 나뉘어요

Part A(25점)는 리더가 알아야 할 비임상 전략·거버넌스·환자정보 판단을 사례형으로 묻습니다. **Part B(55점)**는 가상 의료기관 시나리오를 주고 비임상 AI 운영 실행계획서를 직접 설계하게 하는 핵심 과제예요. **Part C(20점)**는 환자정보 사고·저항 같은 돌발상황 대응을 서술형으로 봅니다.

L1의 승부처는 Part B입니다. **의료기관을 진단하고 비임상 AI 운영·환자정보 보호 체계를 설계하는 실제 문서를 완성**해야 해요. 객관식만으로는 절대 합격할 수 없습니다.



자기 병원 사례가 아니라 "가상 의료기관 시나리오"로 풀어요. 공정성과 환자정보 보호를 위해, 시험이 제공하는 가상 의료기관의 현황·제약·부서·위험사례를 바탕으로 **고정 템플릿**에 실행계획서를 작성합니다. 모든 응시자가 동일 조건이에요. 자세한 내용은 다음 장(5번)에서 안내할게요.

4 어떤 기준으로 문제가 나오나요?

6대 평가영역과 출제 유형

AXIS L2 객관식 30문항은 아무렇게나 출제되지 않아요. **6개의 실무역량 영역**에서 정해진 문항 수만큼 나오고, 각 영역은 실습 과제와도 연결됩니다. 어느 영역이 비중이 큰지 알면 준비 우선순위를 정할 수 있어요.

AXIS-H L1 Part A 객관식 25문항은 아무렇게나 출제되지 않아요. **7개의 리더 역량 영역**에서 골고루 나오고, 이 영역들은 Part B 실행계획서 설계와도 직결됩니다. 어떤 영역을 보는지 알면 실행계획서 준비의 뼈대가 잡혀요.

● 7대 평가영역 (의료기관 리더 역량)

영역 무엇을 보나요?

- 의료기관 비임상 적용범위 설정**
원무·행정·CS·감염안전·홍보·교육 활용범위, 진단·치료로 안 흐르게 경계 설정
- 환자정보 보호·데이터 거버넌스** 🔑
환자명·주민번호·진료정보·민감정보 입력·마스킹 기준, 사용·금지 데이터 구분
- 의료기관 산출물 품질관리**
안내문·CS 문구·감염관리 자료의 검토·승인 체계, 의료행위 오인 차단
- 의료윤리·법적 책임·컴플라이언스** 🔑
민원·책임소재·광고홍보 표현·법적·윤리적 위험 통제
- 부서별 도입전략**
원무·병동행정·간호행정·CS·감염안전·홍보·교육 부서별 과제·금지영역 구분
- 병원 내 변화관리·협업체계**
의료진·행정직·간호부·전산실·보안·QI 다직종 협업·승인 프로세스
- 성과·환자경험·운영지표 관리**
환자경험·민원 감소·응대시간·문서품질·사고 예방 지표 설계

🔑 **환자정보 보호와 의료윤리·컴플라이언스**가 객관식·실행계획서 양쪽에서 비중이 가장 큼니다. 의료기관은 환자정보와 의료행위 오인이 결합된 고위험 환경이라, 리더가 통제 기준을 만들어야 하니까요.

● L1이 의도적으로 "피하는" 시험 유형

L1 기획에는 "이렇게는 출제하지 않는다"가 명시돼 있어요. 무엇을 안 보는지 알면 방향이 분명해집니다.

이런 시험이 아니에요	대신 이걸 봅니다
의료 AI·진단 보조 시험	비임상 적용범위·환자정보·컴플라이언스 설계
임상 의사결정 설계	진단·치료·처방은 설계 대상에서 제외
자유양식 보고서 쓰기	고정 시나리오 + 고정 템플릿 작성
AI 도구 나열 시험	거버넌스·환자정보·의료윤리 설계

즉 L1은 "의료 AI를 잘 아는가"가 아니라 "의료기관의 비임상 AI를 안전하게 설계하는가"를 봅니다.

5 실행계획서·서술형은 어떻게 치르나요?

Part B·C와 채점 방식

L1의 핵심은 **Part B 실행계획서(55점)**입니다. 시험이 제공하는 가상 의료기관의 현황·계약·부서 자료를 읽고, **고정 템플릿**에 따라 비임상 AI 운영 실행계획서를 직접 설계해요. Part C는 돌발상황 대응을 서술형으로 풀니다.

● Part B 실행계획서 — 8개 항목으로 채점돼요 (55점)

실행계획서는 아래 8개 항목을 **고정 루브릭**으로 채점합니다. 각 항목은 구체적 근거가 있어야 점수를 받아요. 이 8개가 곧 실행계획서의 목차입니다.

실행계획서 항목	배점
① 의료기관 현황·문제 진단	7점
② 비임상 적용범위와 금지경계 🔑	9점
③ 부서별 AI 적용 과제 선정	7점
④ 환자정보 보호·데이터 기준 🔑	9점
⑤ 의료기관 거버넌스·승인체계	7점
⑥ 의료윤리·법적책임·리스크 통제 🔑	10점
⑦ 교육·변화관리·협업전략	4점
⑧ KPI·성과관리·사후개선	2점

🔑 ② 비임상 적용범위·금지경계(9점), ④ 환자정보 보호(9점), ⑥ 의료윤리·법적책임(10점)이 가장 비중이 큼니다. 의료기관 특유의 위험을 통제하는 게 리더의 핵심 책무예요.

● Part C 서술형 — 돌발상황 대응 (20점)

서술형 2문항은 "환자정보가 유출됐다", "직원들이 AI 도입에 저항한다", "성과가 부진하다" 같은 **돌발상황**을 주고 어떻게 대응할지 묻습니다. 아래 5가지를 봐요.

채점 요소	무엇을 보나요?
상황 인식	문제의 성격·영향범위·이해관계자를 파악했는가
즉시 조치	중단·격리·보고·영향확인 등 초기 대응이 적절한가
재발 방지	정책·교육·기술통제·승인절차 개선이 구체적인가
커뮤니케이션	내부·외부(환자·보호자 포함) 소통 원칙이 적절한가
실행가능성	책임자·일정·점검지표가 현실적인가

🔑 "문장 미화"가 아니라 "구조·논리·통제"가 점수예요. L1은 AI가 만든 멋진 문장을 보는 게 아니라, **응시자의 비임상 운영설계 판단과 환자정보·의료윤리 통제 기준**을 봅니다. 화려한 표현보다 근거 있는 설계가 합격을 만듭니다.

● 실행계획서, 이렇게 쓰면 점수가 올라가요

각 항목은 '판단 → 근거 → 구체적 실행'으로. 추상적 선언이 아니라 누가·언제·어떻게가 보여야 점수가 됩니다.

👤 약한 설계

✗ "환자정보를 보호하고 AI를 안전하게 쓴다." (선언만, 근거·실행 없음)

👤 좋은 설계

✓ "환자정보 유출·의료행위 오인 위험 → 입력 금지 데이터 지정 + 비식별 기준·산출물 승인 절차 신설, 비임상 적용범위 경계 명시." (판단·근거·실행)

6 어떻게 채점하고, 언제 합격인가요?

배점과 합격 기준

● 합격 기준

70점 ↑

총점 (100점 만점)
이상이면 합격

55점

실행계획서 배점
(Part B)

33점 ↑

실행계획서 권장선
(미만 시 경계검수)

총점 **70점 이상**이면 합격입니다. 핵심은 **Part B 실행계획서**예요. 55점 만점의 실행계획서가 **33점 미만**이면, 총점이 높더라도 추가 검토(경계검수) 대상이 됩니다. 객관식·서술형만 잘하고 정작 조직 설계 능력이 부족한 리더 후보를 걸러내기 위해서예요.



합격 점수는 잠정 기준입니다. 70점·33점 기준은 시험을 정식 운영하며 응시자 점수 분포 분석을 거쳐 최종 확정됩니다. 최신 합격 기준은 응시 전 **axisexam.com**에서 꼭 확인하세요.

● 채점은 이렇게 이뤄져요

1 Part A 객관식 — 자동 채점

정답키에 따라 자동으로 정확하게 채점됩니다.

2 Part B·C — AI 보조채점 + 전문가 검수

고정 루브릭으로 채점하되, **AI 보조채점과 전문가 점수가 다르면 전문가 의견을 우선**합니다.

3 위험 플래그 — 전문가 필수 검수

실행계획서 각 항목에 위험 등급(없음·주의·높음·치명)을 매겨, 위험이 있으면 전문가가 확인합니다.



모든 응시자가 동일한 가상 조직으로 풀어요. 자기 회사 자료를 쓰지 않고 시험이 제공하는 가상 조직 시나리오·고정 템플릿으로 평가하므로, 응시자별 전제 차이나 기밀 위험 없이 **공정하게 채점**됩니다.

7 무엇을 어떻게 준비하면 되나요?

영역별 학습 방향

가장 중요한 준비 원칙은 "의료 AI 지식이 아니라, 비임상 운영 설계를 연습하라"입니다. L1은 의학이나 진단 AI가 아니라, **의료기관의 비임상 AI를 안전하게 운영하는 체계를 설계하는 능력**이 핵심이에요. 가상의 병원을 놓고 "비임상 업무에 AI를 어떻게 안전하게 도입·운영할까"를 실행계획서로 써보는 게 가장 좋은 준비입니다.

● 영역별 학습 방향

평가영역	이렇게 준비하세요
① 비임상 적용범위 설정	AI 활용범위와 진단·치료로 안 흐르는 금지경계를 긋는 연습
② 환자정보 보호·거버넌스 🔑	사용·금지 데이터 구분과 마스킹 기준 설계 (비중 큼)
③ 의료기관 산출물 품질관리	안내문·CS 문구의 검토·승인 체계 를 만드는 연습
④ 의료윤리·법적책임· 컴플라이언스 🔑	광고홍보 표현·책임소재 위험 통제 설계 (비중 큼)
⑤ 부서별 도입전략	원무·간호행정·CS·감염안전 부서별 과제·금지영역 구분
⑥ 변화관리·협업체계	의료진·행정·간호·전산·보안·QI 다직종 협업 설계
⑦ 성과·환자경험·운영지표	환자경험·민원 감소· 사고 예방 지표 계획 연습

● 아이넥스 교육원 아카이브 활용

혼자 준비가 막막하다면, **아이넥스 교육원의 학습 콘텐츠**가 준비 학습의 핵심 기반이 됩니다. 의료기관 AI 거버넌스·환자정보 보호·컴플라이언스 과정을 통해 위 7대 영역의 설계 역량을 체계적으로 키울 수 있어요.

※ 단, 이론을 "읽기"만 하지 말고 **가상 의료기관을 놓고 비임상 AI 운영 실행계획서를 직접 작성**해보는 방식으로 준비하는 것이 AXIS-H L1 시험 성격에 맞습니다.



무료 데모 응시로 미리 경험해 보세요! AXIS는 실제 시험과 같은 환경을 **최대 2회 무료로 체험**할 수 있는 데모 응시를 제공합니다. 실행계획서 템플릿과 서술형 형식을 미리 겪어보면 실전에서 훨씬 편안해요. axisexam.com에서 신청하세요.

8 시험 볼 때 주의할 점은?

본인확인 절차와 흔한 실수

● 응시 전 — 5단계 본인확인을 거쳐요

AXIS는 온라인으로 편하게 응시하지만, 공정성을 위해 본인확인 절차가 있습니다. 미리 알아두면 당황하지 않아요.

1 NICE 본인인증

본인 명의로 접수자와 응시자가 같은지 확인합니다.

2 신분증 확인 (OCR)

신분증의 이름·생년월일·사진을 인식합니다.

3 얼굴 대조

신분증 사진과 실시간 얼굴을 비교합니다.

4 AI 실시간 모니터링

시험 중 화면 이탈 등을 영상으로 확인합니다.

5 무효 기준 적용

위반 시 경고·시험 종료 기준이 적용됩니다.

● 미리 준비할 것 & 하면 안 되는 것

✓ 미리 준비하세요

- ✓ 신분증 (본인확인용)
- ✓ 카메라 (얼굴 대조·모니터링)
- ✓ 안정적인 인터넷 연결
- ✓ 혼자 집중할 조용한 장소

⊘ 이러면 무효될 수 있어요

- ✗ 카메라를 가리거나 끄기
- ✗ 시험 화면을 벗어나기
- ✗ 다른 사람이 대신 응시
- ✗ 감독(모니터링) 방해

● 흔한 실수 — 이것만 피하세요

- 실행계획서에 시간 몰아쓰기 실패 — Part B가 60분입니다. 객관식·서술형에 시간을 너무 쓰면 정작 핵심인 실행계획서를 놓쳐요.
- 8개 항목 중 일부 누락 — 실행계획서는 8개 항목으로 채점됩니다. 한 항목이라도 비우면 점수를 크게 잃어요. **템플릿 항목을 모두** 채우세요.
- 환자정보·의료윤리 소홀 — 가장 배점이 큰 항목이 비임상 금지경계·환자정보 보호·의료윤리예요. **이 세 가지를 반드시** 구체적으로 쓰세요.
- 임상 영역으로 흐르기 — 진단·치료·처방을 설계에 넣으면 안 됩니다. **비임상 경계**를 지키세요.
- 환경 점검 누락 — 카메라·마이크·네트워크는 **시작 전에** 반드시 확인하세요.



준비되셨나요? 전체 그림이 잡혔다면, 이제 axisexam.com에서 무료 데모 응시로 실행계획서 템플릿을 익히고 실전에 도전해 보세요. 의료기관의 안전한 AI 운영을 설계하는, **리더로** — AXIS가 함께합니다!

9 시험이 끝나면, 그다음은?

결과 확인 · 자격증 · 재응시 · 다음 단계

● 결과는 언제, 어떻게 확인하나요?

L1은 실행계획서·서술형을 전문가가 검수하므로, **결과 발표까지 며칠**이 걸릴 수 있어요. 발표되면 마이페이지에서 합격 여부·총점과 함께 **Part A·B·C 영역별 점수**를 리포트로 확인할 수 있습니다.

● 자격증과 재응시

- **자격증 발급·검증** — 합격 시 자격증이 발급되고, 진위를 확인하는 자격검증 기능을 제공해 리더 역량 증빙 자료로 쓸 수 있어요.
- **유효기간 3년** — 만료 전 **무상 보수 응시**로 3년 연장할 수 있습니다.
- **재응시 2회 (무료)** — 아쉽게 떨어져도 최초 응시 외 최대 2회까지, 재응시료 없이 다시 도전할 수 있어요.

※ 결과 발표·재응시 일정 등 세부 기준은 axisexam.com 공지 기준을 따릅니다.

● L1 다음은? — 리더로서 이렇게 확장하세요

- **유효기간 내 재검정** — 3년 유효기간 만료 전 보수 응시로 최신 기준에 맞춰 자격을 유지하세요.
- **의료기관 내 비임상 AI 확산 주도** — 취득한 설계 역량으로 원무·CS·행정 등 부서별 AI 도입과 환자정보 거버넌스를 실제로 이끌어 보세요.
- **타 영역 리더 자격** — AXIS L1(일반 업무)·AXIS-C L1(코딩·자동화)으로 리더 역량의 폭을 넓힐 수 있어요.

? 자주 묻는 질문 · **L2를 꼭 먼저 해야 하나요?** 초기엔 관리자 경력·교육 이수로 예외 응시가 가능해요. · **임상 의사결정도 설계하나요?** 아니요, 진단·치료·처방은 설계 대상에서 제외돼요. · **떨어지면?** 실행계획서 보완 후 재응시 (2회·무료).



준비되었나요? 전체 그림이 잡혔다면, 이제 axisexam.com에서 무료 데모 응시로 실행계획서 템플릿을 익히고 실전에 도전해 보세요. 의료기관의 안전한 AI 운영을 설계하는, **리더로** — AXIS가 함께합니다!